Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent16vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5055767-07.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: GERDA BLAUTH

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

1) RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por GERDA BLAUTH em face de UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA. Alega que é beneficiária do plano de saúde UNIMED Empresarial Global Ambulatorial-Hospitalar com obstetrícia, sob a matrícula nº 00482008535006400 (evento 1, OUT6). Refere que é portadora de Linfoma não-Hodglin difuso (CID 83.3), razão pela qual está está internada no Hospital Mãe de Deus desde 03/09/2021. tendo realizado a primeira linha de quimioterapia para o controle da enfermidade. Disse que após o término do tratamento, verificou-se o surgimento de lesão no crânio e envolvimento do sistema nervoso central. Por conta disso, necessita de tratamento quimioterápico com o fármaco TEMODAL (TEMOZOLAMIDA) em compridos de 250mg e 20mg por 05 ciclos, visto que é medicamento com ação no sistema nervoso central e, por conseguinte, capaz de tratar a doença que lhe acomete. Contudo, ao solicitar o fornecimento do medicamento à requerida, o pedido foi indeferido sob a fundamento de que trata-se de hipótese de prescrição *off label* - evento 1, RESJUSTADMIN7. Ao final requereu: i) a tramitação preferencial fundamentada em doença grave; ii) a benesse da gratuidade da justiça; iii) em sede de tutela provisória de urgência, o fornecimento do medicamento TEMODAL (TEMOZOLAMIDA) em comprimidos de 250mg e 20mg, na qualidade e quantidade prescrita pelo médico assistente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais); e iv) no mérito, a confirmação da obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do fármaco. Juntou, dentre outros documentos, laudo do médico que a acompanha - evento 1, LAUDO9 -, receita médica prescrevendo o medicamento - evento 1, RECEIT10 - e estudo científico acerca da efetividade da medicação ao tratamento de sua doença - evento 1, OUT11 -.

Concedida a tutela provisória de urgência no evento 3, DESPADEC1.

Citada, a demandada apresentou defesa, arguindo: i) a licitude da sua conduta em razão da ausência de previsão contratual e legal para fornecimento de medicações *off labe*l; ii) a ausência de violação às normas consumeristas; iii) a desnecessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que a medida "*se mostra sobremaneira inócua, eis que o objetivo pro atrás do instituto processual já foi atendido, qual seja, a paridade informações ao dispor das partes*". Anexou o contrato de adesão - evento 11, CONTR2 - e o parecer da assessoria jurídica - evento 11, PARECER3 -.

Réplica no evento 15, RÉPLICA1 .

Intimadas acerca do interesse na produção de provas - evento 17, DESPADEC1 -, ambas responderam negativamente - evento 21, PET1 e evento 22, PET1 -.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Relatei.

Decido.

2) FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente cumpre consignar a **aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguros e de planos de saúde**: Trata-se de entendimento sumulado pelo STJ Súmula n. 608 do STJ[1]

Dessa forma, inquestionável a identificação das seguradoras ou operadoras de planos de saúde como fornecedoras de serviço e dos beneficiários (segurados) como consumidores, nos termos do que dispõem os artigos 2º, "caput"[2], e 3º, §2º[3], da legislação consumerista.

Com efeito, os contratos de seguro e planos de assistência à saúde devem necessariamente se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para fins de evitar eventual desequilíbrio entre as partes, bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

Portanto, na hipótese, a relação jurídica travada entre as partes está jungida às normas protetivas do referido diploma legal, com destaque àquelas atinentes:

- Interpretação mais favorável à parte aderente (art. 47)[4];

- Abusividade (e consequente nulidade) das cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema (art. 51, incisos IV e XV, e § 1º, incisos, I a III)[5].

- Presunção de vulnerabilidade do consumidor **(art. 4°, I)**[6] que, inclusive, enseja a inversão do ônus da prova **(art. 6°, VIII)**[7];

- Boa fé (**art. 4°, III)**[8], também prevista no **Código Civil (art. 422)**[9]**;**

- Função social do contrato, **(art. 51, par 1°, II)**[10] também prevista no **art. 421, do Código Civil)**[11]**.**

Aliás, com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao planos de saúde, transcrevo a lição de Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem[12]

> *"O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º do Código. Daí porque o STJ tenha superado as discussões dogmáticas sobre a natureza do contrato, como seguro ou plano, e tem decidido impor a este importante tipo contratual de consumo de massa uma boa-fé extremamente qualificada, exigindo de todos os fornecedores (operadoras, seguradoras e outros), o cumprimento do dever de informação, cooperação e cuidado. (...) se de um lado é certo que a necessidade de manter equilíbrio econômico-atuarial do contrato, em vista da previsão de riscos e probabilidades, e a respectiva sustentabilidade econômica que lhe assegure – tema que pertence à expertise do fornecedor - também é correto determinar a estes contratos uma interpretação conforme à boa-fé e sempre a favor do consumidor."*

Outrossim, indubitável a aplicação da Lei nº 9656/98 ao contrato objeto da lide em apreço, uma vez que firmado após a sua vigência.

A referida Lei determina que as coberturas de procedimentos médicos e medicamentos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12, e, por outro lado, não pode impor a previsão das coberturas elencadas no art. 10. Não obstante, evidentemente que oas avenças firmadas podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive no sentido de abarcar as hipóteses do citado art. 10.

Especificamente no que tange à cobertura de medicamentos, transcrevo os dispositivos que determinam às operadoras de saúde a obrigação de fornecer os medicamentos necessários ao paciente quando de uso hospitalar, excluindo tal a obrigação quando forem de uso domiciliar, **salvo os relativos a tratamentos antineoplásicos**, caso em que devem ser observados os protocolos e diretrizes da ANS. *In verbis:*

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *(...)*
>
> *V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*
>
> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *(...)*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *(...)*
>
> *d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;*
>
> *(...)*
>
> *g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;*
>
> *(...)*

§ 4º As coberturas a que se referem as alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II deste artigo serão objeto de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, revisados periodicamente, ouvidas as sociedades médicas de especialistas da área, publicados pela ANS

§ 5º O fornecimento previsto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II deste artigo dar-se-á, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e de acordo com prescrição médica.

Pois bem.

Rememorando os fatos, a autora pleiteia a cobertura de medicamento para tratamento de Linfoma não-Hodglin difuso (CID 83.3), nomeadamente Temozolamida (Temodal), **fármaco antineoplásico**. A cobertura foi negada em razão de não haver na bula prescrição específica para a CID indicada (*off label*).

Considero ilegal a referida negativa. Isto porque, com fulcro nos dispositivos consumeristas supra citados, a jurisprudência solidificou o entendimento de que incumbe ao(à) médico(a) assistente a indicação do tratamento que melhor se adapta ao seu caso, **não podendo um tratamento ou fármaco ser negado em razão de sua utilização não estar padronizada para o caso ou prevista na bula.**

Nesse sentido, exemplificativamente, destaco o precedente do Superior Tribunal de Justiça **que trata, inclusive, sobre mesmo fármaco (Temodal)**, com meus grifos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. CONCRETO AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE QUE SE ENCONTRAVA COM A SAÚDE DEBILITADA POR NEOPLASIA MALIGNA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 18/05/15. Recurso especial interposto em 10/02/17 e concluso ao gabinete em 16/11/17. 2. ***Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Temodal para tratar neoplasia maligna do encéfalo, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.*** *3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. O recurso especial não é a via adequada para revisão dos fatos delineados de maneira soberana pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). 7. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 8.* ***Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.*** *9.* ***O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.*** *10. A* ***ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).*** *11.* ***A recorrida detectou o ressurgimento de um problema oncológico que imaginava ter superado e recebeu recomendação médica de imediato tratamento quimioterápico, com utilização do Temodal, sob pena de comprometimento de sua saúde. Esta delicada situação em que se encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu histórico clínico. Configurado o dano moral passível de compensação.*** *12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018)*

Nessa mesma senda:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O FATO DE A MEDICAÇÃO SER "OFF LABEL", OU SEJA, EMPREGADA PARA USO CUJA INDICAÇÃO NÃO ESTÁ NA BULA, NÃO CONSTITUI ÓBICE AO SEU FORNECIMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE QUANDO A DOENÇA DO PACIENTE NÃO CONSTAR NA BULA DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO QUE MINISTRA O TRATAMENTO (USO "OFF-LABEL") (AGINT NO ARESP 1.713.784/SP, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 15/3/2021, DJE 7/4/2021). APELO NÃO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50043178420208210004, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-10-2022).

Não bastasse, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) considera que o uso *off label* de medicamentos não é necessariamente incorreto, visto que um medicamento ser aprovado para determinada situação não implica que essa seja a única indicação possível. Inclusive, no tratamento de algumas doenças raras, o uso *off label* será o único viável, uma vez que, devido ao baixíssimo número de casos, essas patologias nunca serão estudadas por ensaios clínicos.

Para maior clareza, colaciono o posicionamento mencionada agência reguladora (grifos meus)[13]:

Cada medicamento registrado no Brasil recebe aprovação da Anvisa para uma ou mais indicações, as quais passam a constar na sua bula, e que são as respaldadas pela Agência. O registro de medicamentos novos é concedido desde que sejam comprovadas a qualidade, a eficácia e a segurança do medicamento, sendo as duas últimas baseadas na avaliação de estudos clínicos realizados para testá-lo para essas indicações.

Quando um medicamento é aprovado para uma determinada indicação isso não implica que esta seja a única possível, e que o medicamento só possa ser usado para ela. Outras indicações podem estar sendo, ou vir a ser estudadas, as quais, submetidas à Anvisa quando terminados os estudos, poderão vir ser aprovadas e passar a constar da bula. Estudos concluídos ou realizados após a aprovação inicial podem, por exemplo, ampliar o uso do medicamento para outra faixa etária, para uma fase diferente da mesma doença para a qual a indicação foi aprovada, ou para uma outra doença, assim como o uso pode se tornar mais restrito do que inicialmente se aprovou.

Uma vez comercializado o medicamento, enquanto as novas indicações não são aprovadas, seja porque as evidências para tal ainda não estão completas, ou porque a agência reguladora ainda as está avaliando, é possível que um médico já queira prescrever o medicamento para um seu paciente que tenha uma delas. Podem também ocorrer situações de um médico querer tratar pacientes que tenham uma certa condição que, por analogia com outra semelhante, ou por base fisiopatológica, ele acredite possam vir a se beneficiar de um determinado medicamento não aprovado para ela.

Quando o medicamento é empregado nas situações descritas acima está caracterizado o uso off label do medicamento, ou seja, o uso não aprovado, que não consta da bula. O uso off label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. ***Há casos mesmo em que esta indicação nunca será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras cujo tratamento medicamentoso só é respaldado por séries de casos. Tais indicações possivelmente nunca constarão da bula do medicamento porque jamais serão estudadas por ensaios clínicos.***

O que é uso off label hoje pode vir a ser uso aprovado amanhã, mas nem sempre isso ocorrerá. O que é off label hoje, no Brasil, pode já ser uso aprovado em outro país. Não necessariamente o medicamento virá a ser aprovado aqui, embora freqüentemente isso vá ocorrer, já que os critérios de aprovação estão cada vez mais harmonizados internacionalmente.

A aprovação no Brasil, porém, pode demorar, por vários motivos, entre os quais o de que o pedido de registro pode ser feito muito mais tarde aqui do que em outros países. Também pode ocorrer que o medicamento receba aprovação acelerada em outro país, baseada na apresentação de estudos preliminares ou incompletos, o que, via de regra, não é aceito pela Anvisa. Por fim, um uso autorizado no Brasil pode ser uso off label em outros países.

A classificação de uma indicação como off label pode, pois, variar temporalmente e de lugar para lugar. O uso off label é, por definição, não autorizado por uma agência reguladora, mas isso não implica que seja incorreto.

Portanto, não prospera o argumento da requerida de se tratar de um tratamento *off label* como justificativa para o indeferimento da cobertura.

Nesse contexto, e tendo em vista as provas apresentadas em juízo, quais sejam:

- Laudo médico que instruiu a petição inicial - evento 1, LAUDO9 - o qual retrata o histórico médico e a **necessidade, a adequação e a urgência** da utilização do famáco postulado ao tratamentoda doença que acomete a autora, e o estudo clínico acerca do tratamento postulado - evento 1, LAUDO9 -, documentos hábeis a comprovar o direito constitutivo da requerente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil; Por outro lado

- Parecer **unilateral** acostado pela ré - evento 11, PARECER3 - o qual não possui o condão de comprovar fato impeditivo/modificativo/extintivo da parte autora, pois apenas ilustra que na bula do medicamento inexiste indicação para o tratamento da enfermidade, sem demonstrar eventual ineficácia/contraindicação/desnecessidade/inadequação;

Dito isso, devida a cobertura, sob pena de não ser atendida a finalidade precípua do contrato, qual seja, a proteção à saúde, direito fundamental protegido constitucionalmente[14].

3) DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONFIRMO** a tutela de urgência concedida no evento 3, DESPADEC1 e, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil[15], **JULGO PROCEDENTE** o pedido inicial para condenar a **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA** ao fornecimento do medicamento TEMOZOLAMIDA (TEMODAL), na quantidade indicada pelo médico assistente, enquanto necessário.

Sucumbente, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios à procuradora da parte adversa, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à demanda, considerando a natureza da demanda, o grau de zelo e o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como o tempo de duração do processo, nos termos do disposto pelo art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Os honorários deverão ser corrigidos pelo IGP-M desde a data da sentença, bem como acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Publicação, registro e intimação realizados pelo sistema eletrônico.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **ELIANE GARCIA NOGUEIRA, Juíza de Direito**, em 14/3/2023, às 13:41:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10031148982v31** e o código CRC **c279bfc0**.

---

1. Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ↩
2. Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. ↩
3. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. ↩
4. Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. ↩
5. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. ↩
6. Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; ↩
7. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:(...)VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; ↩

8. Art. 4º (...)III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; ↩

9. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ↩

10. Art. 51 (...) § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. ↩

11. Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato ↩

12. Direito dos Seguros: fundamentos do direito civil: direito empresarial e direito do consumidor/ coordenação: Bruno Miragem e Angélica Carlini.- SP, Ed. Revista dos Tribunais, 2014. ↩

13. Disponível em http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=2863214&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=uso-off-label-de-medicamentos&inheritRedirect=true. ↩

14. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. ↩

15. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; ↩